

جوستاف روسي انترناسيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : سحر محمد مختار محمود

العنوان : 36 ح ابو مسعد البقال
امياه

الحى / المدينة : امبايه

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

رقم البطاقة : 26709271200185 رقم التليفون : 01125174848

العمر (تاريخ الميلاد) : 27-09-1967 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (_____)

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعة مقطعية صدر مع صبغة [10851] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص :-----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: _____ التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس

وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعمد صحة البيانات المرفوعة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / د ----- / د ----- / د. | ----- / د. |

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطّة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

قسم :

نَفَقَات :

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: سحر محمد مختار محمود National ID: 26709271200185	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of the chest .
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



سحر
محمد مختار محمود
٣٦ ح ابو مسعد البقال
امبابه - الجيزة

١٩٦٧/٠٩

٢٦٧.٩٢٧١٢.٠١٨٥

LD3962701

عينة



٢٠٢٥/٠٥ ٢٦٧.٩٢٧١٢.٠١٨٥

ربة منزل



أنثى
مسلمة
محمد عبد المنعم ارج موسى

البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٥/٠٩



١١٢٥١٧٤٨٤٨

١٠١١٦٢١٩٤٧

رقم التليفون: ١١٤٥١٧٤٨٤٦
الرقم القومي: ٩٢٧١٢٠١٨٥
الاسم: نسر محمد مختار محمد
التاريخ: ٢٦٧

○ مستهدفة بالانجنيون

الوزن	الطول	مؤشر كتلة الجسم	قياس السكر العشوائي	قياس ضغط
			118	2/2

***فكري نفسك باستمرار بموعد الفحص الذاتي شهرياً**

2019	سبتمبر	2019	أغسطس	2019	يوليو
2019	ديسمبر	2019	نوفمبر	2019	أكتوبر
2020	مارس	2020	فبراير	2020	يناير
2020	يونيو	2020	مايو	2020	أبريل
2020	سبتمبر	2020	أغسطس	2020	يوليو
2020	ديسمبر	2020	نوفمبر	2020	أكتوبر
2021	مارس	2021	فبراير	2021	يناير
2021	يونيو	2021	مايو	2021	أبريل

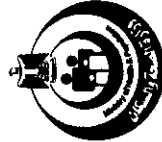
- حافضي علي قياس السكر والضغط مرة كل ٦ شهور.
- إذا كنتي في سن الزواج أو الإنجاب، استشري طبيب بانتظام الأسرة.
- إطمني، الكشف المبكر يساعد في السيطرة على الأمراض، وزيادة نسب الشفاء.

المكان المدة له لتقييم:
موعد الفحص القادم:
توقيع الطبيب:
موعد التقييم:



21

رستم
 خجسته
 حرمه
 قیامگاه



منظمة الصحة العالمية

Name sahar mohamed mokhtar

Date 11/06/2026

**DIGITALIZED LOW DOSE SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY
WITH COMPLEMENTARY BREAST US EXAMINATION OF
BOTH BREASTS REVEALED:**

- ACR B: Mixed fibroglandular breast parenchyma.
- An ill-defined hypodense lesion is seen at the UOQ of the right breast corresponding by US to an ill defined spiculated shaped heterogeneous hypoechoic lesion is seen at 9 to 12oclock . It measures 5x5.08 cm, another lesion seen adherent to the previous lesion spiculated with irregular borders, it measures 3x2cm at 12 o'clock with increase vascularity by colour doppler .
- The surrounding tissue shows echogenic fat ,tissue edema and increase skin thickness 0.79cm ,peau d,orange
- No left breast solid or cystic lesions.
- Normal central ducts system.
- Right axillary enlarged pathological lymph nodes, some of them with lost of fatty hilum largest 5x2 cm and other with eccentric hilum ,it measures 2.76x2.34cm cortical thickness 1.26 cm .

Opinion:

- Right breast UOQ suspicious lesions (BIRADS IVa) with pathological lymph nodes and surrounding tissue edema ; for biopsy and Dynamic MRI and pathological correlation.

Much Obligated;

m/11/06/2026 F/1/1

BIRADS scoring is the breast imaging and reporting data system for classifying the radiological diagnosis of breast lesions:

BIRADS 0 : Needs further investigations,

BIRADS 1: Normal findings.

جوستاف
روستاف
في قسم أمراض النساء



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

المنشأة المصرية
للصحة

09/20/2026

MDT FORM

Name:	سن محمد مختار محمد	MRN:	12145
Age:	59 Y	ID:	26709271200185
Menopausal Sta	POSTMENOPAUSAL	Phone:	01125174848
NRS SCORE:		Marital Status:	MARRIED
BMI:		Family History:	HER SISTER LEUKEMIA
CO Morbidity:	HTN AND HCV TREATED AND RA	Reason Of MDT:	NEW CASE

Clinical Data:

R

BX: IDC G 3

ER: 3/8 PR: 5/8 HER2: +3 KI67: 70%

Sonomammography:

Mets Workup:

A CASE OF RT BREAST CANCER , CT4B N2M0
HER+VE

METASTATIC WORK UP CT CAP WITH CONTRAST 7/2026 : LT LUNG UPPER
LOBE NODULE 1.5*1.5 CM AND NO OTHER DISTANT METS

BONE SCAN REQUESTED TODAY

bone scan free

History:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

to start taxol weekly/ herceptin IV
meanwhile for a new FU ct scan to assess the pulm nodules
re mdt after

TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. حنان عزت					

Name : Sahar Mohammed Mokhtar Mahmoud
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Date : 04-09-2026 09:14
Medical No. : 454150

Tc-99m MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History :

59 year-old female patient, who gave history of right breast cancer, complains of bone ache and referred for skeletal survey.

Technique :

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of 20 mCi of the tracer.

Findings:

- No evidence of focal active or cold osseous lesion that would account for bone secondaries.
- Exaggerated degenerative features are depicted at different levels of the spine.
- Osteoarthritic changes are noticed around big joints.

IMPRESSION:

- No definite osseous metastasis could be depicted on scintigraphic basis.

Much obliged
Dr. Alaa Nagy, MD,
Nuclear medicine

جوستاف
روستاف
في قسم أمراض النساء



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الهيئة العامة
لصحة
مصر

09/20/2026

MDT FORM

Name:	سن محمد مختار محمد	MRN:	12145
Age:	59 Y	ID:	26709271200185
Menopausal Sta	POSTMENOPAUSAL	Phone:	01125174848
NRS SCORE:		Marital Status:	MARRIED
BMI:		Family History:	HER SISTER LEUKEMIA
CO Morbidity:	HTN AND HCV TREATED AND RA	Reason Of MDT:	NEW CASE

Clinical Data:

R

BX: IDC G 3

ER: 3/8 PR: 5/8 HER2: +3 KI67: 70%

Sonomammography:

Mets Workup:

A CASE OF RT BREAST CANCER , CT4B N2M0
HER+VE

METASTATIC WORK UP CT CAP WITH CONTRAST 7/2026 : LT LUNG UPPER
LOBE NODULE 1.5*1.5 CM AND NO OTHER DISTANT METS

BONE SCAN REQUESTED TODAY

bone scan free

History:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

to start taxol weekly/ herceptin IV
meanwhile for a new FU ct scan to assess the pulm nodules
re mdt after

TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. حنان عزت					

Name : Sahar Mohammed Mokhtar Mahmoud
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Date : 04-09-2026 09:14
Medical No. : 454150

Tc-99m MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History :

59 year-old female patient, who gave history of right breast cancer, complains of bone ache and referred for skeletal survey.

Technique :

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of 20 mCi of the tracer.

Findings:

- No evidence of focal active or cold osseous lesion that would account for bone secondaries.
- Exaggerated degenerative features are depicted at different levels of the spine.
- Osteoarthritic changes are noticed around big joints.

IMPRESSION:

- No definite osseous metastasis could be depicted on scintigraphic basis.

Much obliged
Dr. Alaa Nagy, MD,
Nuclear medicine

جوستاف
روستاف
في قسم أمراض النساء



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الهيئة العامة
لصحة
مصر

09/20/2026

MDT FORM

Name:	سن محمد مختار محمد	MRN:	12145
Age:	59 Y	ID:	26709271200185
Menopausal Sta	POSTMENOPAUSAL	Phone:	01125174848
NRS SCORE:		Marital Status:	MARRIED
BMI:		Family History:	HER SISTER LEUKEMIA
CO Morbidity:	HTN AND HCV TREATED AND RA	Reason Of MDT:	NEW CASE

Clinical Data:

R

BX: IDC G 3

ER: 3/8 PR: 5/8 HER2: +3 KI67: 70%

Sonomammography:

Mets Workup:

A CASE OF RT BREAST CANCER , CT4B N2M0
HER+VE

METASTATIC WORK UP CT CAP WITH CONTRAST 7/2026 : LT LUNG UPPER
LOBE NODULE 1.5*1.5 CM AND NO OTHER DISTANT METS

BONE SCAN REQUESTED TODAY

bone scan free

History:

Recommendations:

MDT Outcome & Plan

to start taxol weekly/ herceptin IV
meanwhile for a new FU ct scan to assess the pulm nodules
re mdt after

TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. حنان عزت					

Name : Sahar Mohammed Mokhtar Mahmoud
Branch : Dokki
Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Date : 04-09-2026 09:14
Medical No. : 454150

Tc-99m MDP SKELETAL SCINTIGRAPHY

History :

59 year-old female patient, who gave history of right breast cancer, complains of bone ache and referred for skeletal survey.

Technique :

- Anterior and posterior whole body scans were acquired 2 hours post injection of 20 mCi of the tracer.

Findings:

- No evidence of focal active or cold osseous lesion that would account for bone secondaries.
- Exaggerated degenerative features are depicted at different levels of the spine.
- Osteoarthritic changes are noticed around big joints.

IMPRESSION:

- No definite osseous metastasis could be depicted on scintigraphic basis.

Much obliged
Dr. Alaa Nagy, MD,
Nuclear medicine